

Cours De Résidanat

Sujet : Les œdèmes

Professeure Agrégée Manel Ben Salah

Service de Néphrologie, CHU de Monastir

1) À l'état d'équilibre physiologique:

- A. Le secteur intracellulaire comporte 1/3 de l'eau corporelle
- B. L'eau totale représente 80% du poids du corps
- C. Le sodium est l'ion prédominant du secteur extracellulaire
- D. Le transfert du sodium à travers la membrane cellulaire est passif et actif
- E. Les mouvements d'eau à travers les milieux du corps sont régis par la pression osmotique

2) Concernant les échanges entre le secteur vasculaire et le liquide interstitiel:

- A. Ils sont régis par la loi de Starling
- B. Ils sont conditionnés par la pression de filtration et la perméabilité capillaire
- C. La pression de filtration est la résultante des pressions oncotique et osmotique
- D. La pression oncotique est engendrée par le flux sanguin traversant le capillaire
- E. La pression de filtration est positive à + 10 mmHg au pôle artériolaire

3) La formation de l'œdème implique:

- A. Une diminution de la pression hydrostatique
- B. Une augmentation de la pression oncotique
- C. Une altération de la perméabilité capillaire
- D. Une saturation du système lymphatique
- E. Une rétention hydro sodée par le rein

4) Les réponses justes concernant le type de l'œdème dans les pathologies suivantes sont:

- A. L'insuffisance rénale aiguë sévère donne un œdème de stase
- B. Le lymphœdème d'un membre après curage ganglionnaire est un œdème de stase
- C. La thrombophlébite donne un œdème inflammatoire et de stase
- D. La malabsorption digestive donne un lymphœdème
- E. Les inhibiteurs calciques dihydropyridiniques donnent un œdème d'hyper débit capillaire

5) les circonstances de découverte de l'œdème sont:

- A. La perte de poids
- B. L'augmentation du volume de l'abdomen
- C. La lourdeur des membres inférieurs
- D. Une douleur thoracique
- E. Des paresthésies des doigts

6) Le syndrome cave supérieur est évoqué chez un patient ayant un œdème du tronc devant

- A. Des Céphalées intenses
- B. Des veines du cou dilatées
- C. Circulation collatérale pelvienne
- D. Adénopathie sus claviculaire
- E. Visage congestionné

7) un lymphoedème:

- A. Peut être primitif
- B. Peut se voir après curage ganglionnaire
- C. Peut être secondaire à une compression lymphatique par une tumeur pelvienne
- D. Peut être secondaire à une hypothyroïdie
- E. Peut être secondaire à la prise d'AINS

8) les médiateurs suivants sont incriminés dans l'œdème par altération de la perméabilité capillaire:

- A. Bradykinine
- B. Adrénaline
- C. Histamine
- D. Facteur atrial natriurétique
- E. Aldostérone

9) L'œdème angioneurotique:

- A. Survient chez des patients atopiques
- B. Est récidivant
- C. Est déclenché par l'exposition à un allergène alimentaire ou médicamenteux
- D. Peut s'associer à une urticaire prurigineuse
- E. Peut durer quelques jours

10) Identifier les propositions établissant une corrélation entre des éléments de l'anamnèse et une étiologie spécifique de l'œdème

- A. Un œdème aigu douloureux d'un membre chez une femme en post partum doit évoquer un lymphoedème
- B. Un œdème bilatéral des membres inférieurs d'installation progressive doit évoquer une thrombose veineuse profonde
- C. Un œdème bilatéral chez une femme obèse, ayant des varices des membres inférieurs doit évoquer une insuffisance veineuse chronique
- D. L'association d'un œdème douloureux unilatéral à une fièvre et un intertrigo inter orteils doit évoquer un érysipèle
- E. Un œdème récidivant migrant chez un patient sous BSRAA doit évoquer un œdème angioneurotique

11) Les éléments cliniques de présomption de l'origine veineuse d'un œdème sont:

- A. La prédominance en fin de journée
- B. La disparition complète le matin
- C. La redistribution dans les lombes au réveil
- D. L'association à des varices ou des ulcères variqueux
- E. Le caractère blanc, mou, symétrique, déclive, indolore et prenant le godet

12) Les éléments cliniques suivants sont en faveur de l'origine lymphatique d'un œdème

- A. L'installation progressive
- B. La possibilité de plisser la peau des orteils
- C. La consistance initiale est élastique
- D. L'association à une rougeur et une chaleur locale
- E. Le caractère dur et constant des œdèmes anciens

13) Les éléments cliniques en faveur du diagnostic de l'œdème de Quincke sont:

- A. Œdème aigu de la face et du cou blanc mou et indolore
- B. L'association à une dyspnée
- C. L'association à un érythème prurigineux
- D. La mise en évidence d'adénopathies sus claviculaires
- E. La mise en évidence d'une fièvre à l'examen

14) Le diagnostic d'œdème angioneurotique est évoqué devant

- A. Le caractère aigu et récidivant de l'œdème
- B. Le caractère inflammatoire de l'œdème
- C. L'association à une urticaire
- D. L'association à une douleur abdominale parfois pseudo-chirurgicale
- E. L'association à une adénopathie satellite

15) L'algodystrophie est évoquée devant:

- A. Un œdème unilatéral d'un membre
- B. La présence d'une chaleur et de moiteur locales
- C. L'impotence fonctionnelle du membre œdématié
- D. La présence d'une fièvre
- E. La notion de traumatisme ancien du membre concerné

16) les caractéristiques cliniques de l'œdème généralisé sont:

- A. L'association à une prise de poids
- B. Le caractère blanc, gardant le godet
- C. La consistance élastique
- D. La disparition complète le matin
- E. La prédominance au niveau des chevilles en fin de journée

17) Les étiologies de l'œdème généralisé sont:

- A. L'insuffisance cardiaque gauche
- B. Le syndrome néphritique aigue
- C. L'insuffisance rénale aigue sévère
- D. L'entéropathie exsudative
- E. L'insuffisance surrénalienne aigue

18) Les étiologies suivantes sont responsables d'œdème suite à une malabsorption:

- A. La maladie de Crohn
- B. La Résection étendue du grêle
- C. L'Insuffisance pancréatique exocrine
- D. La diverticulose colique
- E. Le Reflux gastro-œsophagien

19) Les médicaments suivants peuvent être responsables d'œdème généralisé:

- A. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
- B. Les corticoïdes
- C. Les inhibiteurs calciques dihydropyridiniques
- D. les B bloquants
- E. L'insuline

20) Les anomalies cliniques suivantes orientent vers un œdème d'origine cardiaque

- A. L'hépatalgie à l'effort
- B. Le reflux hépato-jugulaire
- C. Abolition des murmures vésiculaires à droite
- D. Hypertension artérielle grade 3
- E. Palpitations

21) Les anomalies cliniques suivantes orientent vers un œdème d'origine hépatique:

- A. Circulation veineuse collatérale
- B. Ascite
- C. Hépatomégalie
- D. Angiome stellaire
- E. Vésicule biliaire palpable

22) Les anomalies cliniques et biologiques suivantes orientent vers un œdème d'origine rénale:

- A. L'hypertension artérielle
- B. L'hématurie
- C. Une insuffisance rénale aigue fonctionnelle grade 1
- D. Une albumine à 25 g/l
- E. Un rapport albumine sur créat urinaire à 25 mg/g

23) Chez un patient ayant un œdème le diagnostic d'entéropathie exsudative est évoqué devant:

- A. ascite
- B. Diarrhée chronique
- C. Hypoalbuminémie
- D. Hypergammaglobulinémie
- E. Lymphopénie

24) Les examens paracliniques suivants permettent de rattacher l'œdème à une origine cardiaque:

- A. Échographie trans thoracique
- B. BNP
- C. ECG
- D. Radiographie de thorax
- E. D Dimères

25) Les examens paracliniques suivants permettent de rattacher l'œdème à une origine hépatique:

- A. L'albumine
- B. le taux de prothrombine
- C. Le dosage des triglycérides
- D. La glycémie
- E. Le dosage du Facteur V

26) Les examens paracliniques suivants permettent de rattacher l'œdème à une origine rénale:

- A. Une créatininémie
- B. Une albuminémie
- C. Une protéinurie de 24 heures
- D. Des Anticorps antinucléaires
- E. Un ECBU

27) L'œdème serait grave chez un patient ayant:

- A. une insuffisance rénale terminale et une pré tamponnade
- B. Un syndrome hépatorénal associé à un œdème cérébral
- C. Un œdème de Quincke et une dyspnée
- D. Un syndrome néphrotique par lésion glomérulaire minime
- E. Un syndrome néphritique aigue secondaire à une GNA simple

28) Les situations suivantes imposent l'hospitalisation d'un patient ayant des œdèmes

- A. L'association à un OAP
- B. La présence d'une Pleurésie associée à une hypoxie
- C. L'Ethmoïdite aigue
- D. Des membres inférieurs ++ par maladie rénale diabétique avec un DFG= 75 ml/min
- E. Secondaire à Une fasciite nécrosante du membre inférieur

29) devant un œdème blanc, mou indolore du visage vous évoquez:

- A. Un syndrome cave supérieur
- B. Une staphylococcie maligne de la face
- C. Un œdème angioneurotique
- D. Un myxoœdème
- E. Une ethmoïdite aigue

30) Devant un œdème aigu douloureux, unilatéral d'un membre associé à une T=38.2°C on évoque

- A. Une thrombophlébite aigue
- B. Une insuffisance veineuse
- C. Un érysipèle du membre
- D. Un lymphœdème
- E. La prise d'inhibiteur calcique